PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Prévention des risques suicidaires 2025-2027

14-95 DGFiP - Prévenir les risques suicidaires, plan d'actions 2025-2027 — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le plan d'action s'articule autour de 3 axes incluant la connaissance des risques, la réduction des RPS et l'accompagnement des événements graves.
2. Le DUERP doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle ou après un changement majeur et être conservé pendant 40 ans.
3. Un suicide ou une tentative de suicide déclenche systématiquement une enquête de la formation spécialisée du CSA, même si l'événement ne se produit pas sur le lieu de travail.

Contexte et cadre institutionnel

Notion	À retenir
Situation des agents	Communauté de **95 000** agents. Suicides et tentatives particulièrement nombreux au **1er semestre 2025**. Risque suicidaire = suicide, tentative, idées. **RPS** : facteurs relationnels, organisationnels, conditions d'emploi.
Obligations légales	Direction responsable de la **santé physique et psychique**. Références : **art. 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982** et articles **L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3** du code du travail.
Plan 2025-2027	S'inscrit dans la **Grande Cause Nationale 2025** (santé mentale). 3 axes : **axe 1** (connaître conditions/risques), **axe 2** (réduire RPS/prévenir suicide), **axe 3** (accompagner évènements graves).

Méthodes et gouvernance de l'Axe 1

Notion	À retenir
Culture et formation	Intégration de modules dès **2026** ; formation **obligatoire** pour les responsables accompagnant les transformations ; sensibilisation santé mentale à l'**académie des cadres** en **septembre 2026**.
Ressources et partage	Création d'une **bibliothèque des bonnes pratiques** (**Novae** et **Ulysse**) en **2026** ; réseau de **104 facilitateurs** fin **2025** ; module **CVT** dans **ARCHE** en **2026**.
Exploitation DUERP	Obligation légale (**art. 2-1 décret 82-453**, **art. L. 4121-3** code du travail) ; mise à jour **annuelle** ou après **changement majeur** ; conservation **40 ans** ; campagne de recensement exhaustif en **2026**.
Dialogue social	Rôle **consultatif** des formations spécialisées ; réunion annuelle en direction territoriale ; examen du **bilan national** (suicides/tentatives) par la formation spécialisée du **CSA de réseau** dès **2026**.

Indicateurs et échéances clés

98 %
directions ayant saisi les données 2024
dans l'outil **Prévaction** (objectif **100 %**)

40 ans
durée de conservation du DUERP

Réduction des risques et prévention du suicide

Notion	À retenir
Sensibilisation et formation	Déploiement par l'**UROPS** dès **septembre 2025** du programme de **premiers secours en santé mentale**. Catalogue des formations (**ENFiP**, **IGPDE**, **Mentor**, **SEM@FOR**) en **2026**. Numéro national **3114**.
Repérage précoce	Suivi renforcé dès **2026** pour stagiaires **ENFiP** et agents en mobilité (**6 mois**). **Assistants de prévention** : **100 %** de part de mission ; au moins **2** en directions de 1re catégorie.
Accompagnement des agents	Rendez-vous de **veille sociale** annuel dès **2026**. Diffusion en **2025** d'une **fiche réflexe** (retour congé maladie longue durée) et d'une **plaquette** d'aides.
Santé physique et psychologique	Suivi annuel par **médecins du travail** et **RH**. Séminaires/webinaires (**addictions**, **sommeil**) possibles en **2026** via l'opérateur de **protection sociale complémentaire**.

Accompagnement lors d'événements graves

Notion	À retenir
Urgence et suivi	Priorité : accès aux soins (**15**, **112**, **3114**). Suivi pluridisciplinaire et reprise de contact ciblée par la **médecine de prévention**.
Enquête spécialisée	Suicide ou tentative = **évènement grave** → enquête systématique de la **formation spécialisée** (émanation du **CSA**). Préconisations → **PAPRIPACT** ou plan spécifique. Expert extérieur possible (crédits **SSCT**).
Soutien des équipes	Activé par le **médecin du travail** via le **marché national de soutien psychologique** (débriefings, accompagnement individuel/collectif).
Prévention entourage	Limiter l'effet **Werther** (contagion). Le **BCVTD** diffuse un protocole type dès **2025**. Respecter l'effet **Papageno**.

Échéances et outils de prévention

- **2025** : diffusion par le **BCVTD** d'un mémo sur les actions et acteurs mobilisables.
- **2025** : élaboration et diffusion par le **BCVTD** d'un protocole type pour l'entourage proche.
- **2026** : diffusion par les **directions territoriales** d'une fiche repère (droit d'enquête) et d'une trame de rapport d'enquête.
- **2026** : mise à jour du **guide d'enquête sur les conditions de travail** suite à un acte suicidaire.

Acteurs et outils de prévention

Notion	À retenir
Acteurs clés	**Responsable d'unité** (sécurité/santé), **RH** (appui détresse), **Assistant de prévention** (identification risques), **Médecin du travail** (détection troubles/addictions/risques collectifs).
Outils numériques	**ARCHE** (analyse enjeux/ressources), **module CVT** (croisement données 2026), **Sign@lFiP** (signalements agents), **Prévaction** (recensement risques, **98 %** de saisie en 2024).
Méthodologies	**Espace de discussion** (régulation/ANACT), **Projets informatiques** (expérience utilisateur), **Groupe projet local** (réorganisations), **Protocole post évènement** (limiter effet Werther).

Pièges et confusions

⚠ Confondre le rôle du médecin du travail avec celui des autres acteurs alors qu'il assure la surveillance médicale et l'alerte sur les risques collectifs.
⚠ Confondre l'effet Werther de contagion avec l'effet Papageno protecteur lors de la communication post événement.
⚠ Confondre le responsable d'unité avec les services RH qui interviennent en appui dès la détection d'une détresse.
⚠ Croire que les agents formés aux premiers secours en santé mentale remplacent les professionnels de santé alors qu'ils assurent le repérage et l'orientation.

Sigles et définitions

DGFIP	Direction générale des Finances publiques, employeur de 95 000 agents.
RPS	Risques psychosociaux, risques pour la santé physique, mentale et sociale provoqués par des facteurs relationnels et organisationnels.
DUERP	Document unique d'évaluation des risques professionnels, obligation légale pour l'employeur.
PSSM	Programme de Premiers secours en santé mentale visant à former des secouristes capables d'identifier des signes de souffrance psychique.
Effet Werther	Phénomène de contagion par lequel la médiatisation inappropriée d'un évènement suicidaire peut inciter au passage à l'acte.
Effet Papageno	Effet protecteur généré par des précautions dans la manière de relayer un suicide, comme la présentation de voies de recours.

Auto-test

1. Quelle est la durée de conservation du DUERP ?
2. Quel est le pourcentage de directions ayant saisi les données 2024 dans l'outil Prévaction ?
3. Quel programme de premiers secours en santé mentale sera déployé par l'UROPS dès septembre 2025 ?
4. Quelle est la mission de l'application ARCHE ?
5. Combien de facilitateurs constitueront le réseau fin 2025 ?

Réponses : **1.** 40 ans · **2.** 98 % · **3.** Le PSSM · **4.** L'accompagnement relationnel, changement et exploration pour analyser les enjeux d'une situation relationnelle. · **5.** 104

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.